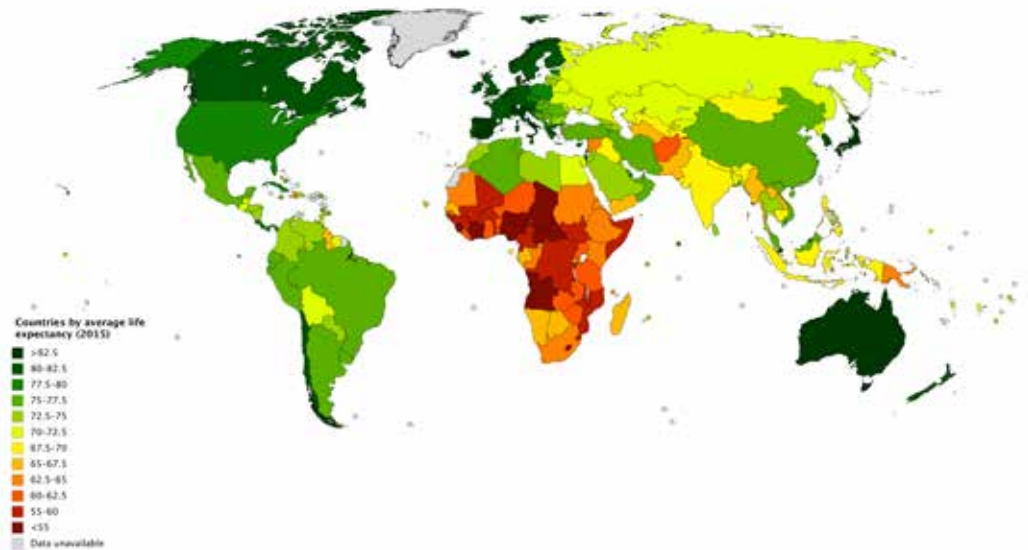


החברה הישראלית היא חברה מורכבת וצוותי מד"א נקראים לטפל באנשים שנמצאים ברגע חולשה בחייהם. מבחינתם אנשי הצוות הרפואי הם אנשים זרים שלא תמיד מכירים את תפיסות עולמם, שפתם והרגליהם, אף שהם זקוקים לעזרתם. קיבצנו בפרק זה קבוצות שונות בחברה שהקשר היחיד ביניהן הוא המגוון האנושי של האוכלוסייה בישראל. מטרתנו היא להציג בפני הצוות הרפואי דגשים שיעזרו לו לתת את הטיפול המקצועי הטוב ביותר - תוך התחשבות במאפיינים ייחודיים של כל אדם ושל כל קבוצה. בפרק זה קובצו כמה קבוצות שיש להן מאפיינים ייחודיים בחברה הישראלית והם ייתנו למטפלים כלים לטיפול בכל אדם, כדי לתת לכל אחד טיפול רפואי שהוא לא רק מקצועי אלא גם אכפתי ומכבד.

קשישים

אחת התופעות הדמוגרפיות הבולטות ביותר בעשרות השנים האחרונות היא הזדקנות האוכלוסייה (תרשים 18.1). שיעור הקשישים מתוך כלל האוכלוסייה הולך ועולה ועוד צפוי להמשיך ולעלות, משנית לעלייה בתוחלת החיים ולירידה בתמותת תינוקות (תרשים 18.2). ארגון הבריאות העולמי הגדיר את התופעה הזו כחגיגה המהולה באתגר. נדמה שאחד האתגרים הגדולים מונח על כתפי המטפלים.

את ההזדקנות אפשר לזהות אך קשה להגדירה. המוסכמה החברתית בנוגע להגדרה של זקנה היא גיל הפרישה (בישראל הוא 62 לנשים, 67 לגברים). אם כי חשוב לזכור שתיתכן אי-התאמה בין הגיל הביולוגי-פיזיולוגי לגיל הכרונולוגי, ולכן יהיו אנשים שיוגדרו קשישים או זקנים בגיל צעיר מאחרים בגלל תחלואה בגיל צעיר או הידרדרות תפקודית מוקדמת, ולהפך, יהיו אנשים שיוגדרו קשישים בגיל מאוחר יותר. לכן, יש להעריך את התמונה הכוללת של האדם שבו מטפלים.

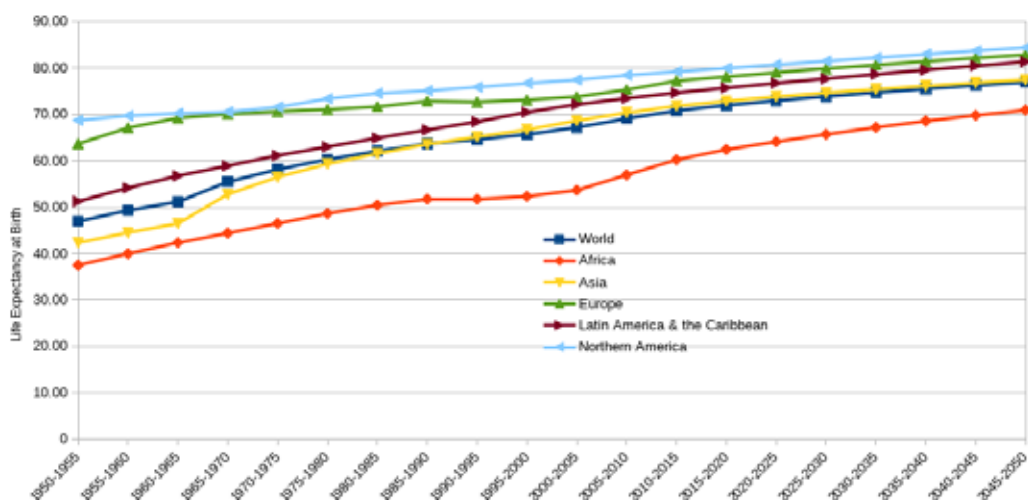


תרשים 18.1 מפת תוחלת חיים עולמית

המפה מציגה את תוחלת החיים הממוצעת במדינות שונות על בסיס נתונים סטטיסטיים שאסף ארגון הבריאות העולמי בשנת 2015. בישראל ובארצות אירופה וקנדה תוחלת החיים הגבוהה בעולם והיא עולה על 80 שנים.

(מזכה: JackintheBox, Own work, CC BY-SA 4.0)

ההזדקנות היא תהליך, היא אינה מתרחשת בן לילה. זוהי ירידה הדרגתית בתפקוד מערכות הגוף. קצב הירידה תלוי במגוון גורמים מולדים, למשל תורשה, בגורמים נרכשים, למשל אורח החיים, ובמשתנים סביבתיים, למשל זיהום סביבתי. בשל הירידה התפקודית נוצרות בעיות מיוחדות המאפיינות אוכלוסייה זו, ולכן ניצב בפני המטפלים אתגר מיוחד בטיפול בקשיש שנפגע מטרומה. האתגר נובע משני גורמים עיקריים: השינויים בבסיס תהליך ההזדקנות והשינויים שעובר הגוף עם ההזדקנות המערכות, ונוספים אליהם גורמים נלווים כגון שימוש נרחב בתרופות (ותיתכן גם תגובה שונה מהצפוי לתרופות ולמינונים מקובלים). גורמים נלווים נוספים יכולים להיות מצב סוציו-אקונומי המורכב מעוני, הזנחה, בדידות. גורמים הקשורים לתהליך ההזדקנות עצמו יכולים להיות מצבים רפואיים המייחדים את גיל הזקנה כגון: דיכאון, דמנציה, אצירת שתן ושכיחות מוגברת של נפילות ושברים. לצד הקשיים התפקודיים הפיזיים תיתכן גם לקות קוגניטיבית המקשה את התקשורת עם המטופל הקשיש. לכן על המטפלים בקשישים להביא בחשבון את כל ההיבטים האלה ולהיות ערוכים לדרישות המיוחדות.



תרשים 18.2 גרף תוחלת החיים לשנים 1960-2050

העלייה המתמדת בתוחלת החיים החל משנת 1960. עלייה זו מביאה עימה אתגרים רבים בטיפול הרפואי בקשישים. התרשים מציג את המגמה בתוחלת החיים עבור כמה אזורים בעולם במשך מאה שנים: משנת 1950 עד 2050. העלייה בתוחלת החיים היא תוצאה של התקדמות תחום בריאות.

(מזכה: (Odogerall, Own work, CC BY-SA 4.0

השינויים המתרחשים במערכות הגוף בתהליך ההזדקנות

תהליך ההזדקנות מתבטא בירידה תפקודית הדרגתית של כל מערכות הגוף, והוא שונה מאדם לאדם. תהליך זה מתחיל סביב העשור השלישי לחיים (גיל 20-30), אך הוא נעשה בולט ונרחב בעיקר כשמגיעים לעשור השישי (גיל 50-60). תהליך זה הוא גורם הסיכון המשמעותי ביותר להופעה של מחלות כרוניות ובסופו של דבר למוות. להלן ייבחנו מערכות הגוף העיקריות והשינויים המתחוללים בהן בתהליך ההזדקנות.

(א) מערכת העצבים והקלט החושי

המוח מתפתח בעיקר בעשרים השנים הראשונות לחיים. עם הגיל מספר הניורונים הולך ופוחת, הקשרים בין התאים הולכים ומצטמצמים ואיתם קטן נפח המוח. הביטוי לכך הוא שמופיעות תופעות רבות המזוהות עם הזקנה דוגמת קהיון חושים, בעיות זיכרון וחשיבה, פגיעה ביכולת הריכוז ובסופו של דבר עיבוד מידע לקוי. ירידה זו בתפקודי מערכת העצבים המרכזית מעלה את הסיכוי לתאונות ונפילות, ועבור המטפל איבוד הזיכרון ויכולת החשיבה של המטופל מקשה לגבש הערכה נכונה של בעיית הנפגע ומצבו, שכן קשה לקבל מידע חשוב על המטופל.

הראייה - היא אחת המערכות המרכזיות שנפגעת בשל משלב ליקויים. ראשית, עכירות העדשה, קטרקט (תמונה 18.1) המופיעה עם הגיל, גורמת לירידה בחדות הראייה. פגיעה נוספת בראייה היא פגיעה בראיית לילה וקושי בהבחנה בין צבעים. נוסף על כך יורדת יכולת תגובת האישונים לשינויים באור, ומתוך כך מופיעים קשיי הסתגלות בעת מעבר בין אזורים עם תאורה שונה. שינויים אלו קורים במקביל לפגיעה בעיבוד של הקלט החושי והאיטיות בתגובה. פגיעה זו בראייה מובילה לקושי בגיבוש תמונה נכונה של המציאות, ועלולה לגרום לצריכת חומרים מסוכנים כגון שתייה בטעות של חומרי ניקוי, היא עלולה לגרום לנטילת תרופה לא נכונה, לנפילות ולסיכון מוגבר לתאונות דרכים.



תמונה 18.1 קטרקט

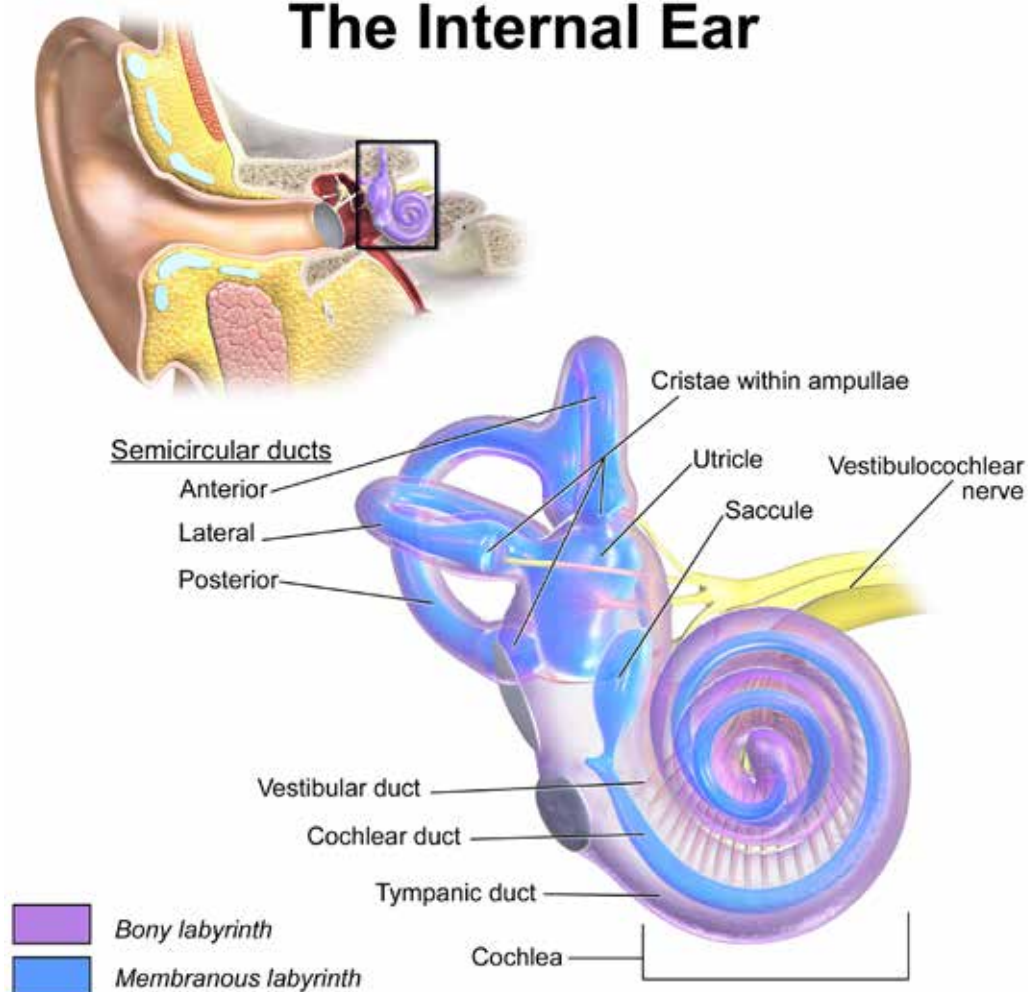
עכירות עדשת העין הגורמת ללקות ראייה עד עיוורון.

השמיעה - לצד הפגיעה במערכת הראייה נפגעת גם מערכת השמיעה. לקות שמיעה היא הפרעה נפוצה בקרב קשישים, והיא שכיחה יותר בגברים. הפרעה זו יכולה להיות משנית למגוון רחב של גורמים ובהם: טראומה, השפעת תרופות, סוכרת, טרשת עורקים, יתר לחץ דם, גידול או הצטברות שעווה באוזן (סיבה שכיחה). פעמים רבות טִנִּטָּן ("צלצולים אוזניים", tinnitus) יכול להיות תסמין לפגיעה זו. ההפרעה נפוצה למדי וגורמת לפגיעה ניכרת באיכות החיים. פגיעה באוזן יכולה לגרום לפגיעה באיזון, כלומר לשיבוש של מרכז שיווי המשקל של הגוף המתבססת על מבנים הקשורים לאוזן (איור 18.1). פגיעה בשיווי משקל גורמת לעמידה יציבה פחות, להליכה איטית יותר ומתנדנדת. אם כן, הפגיעה באוזן היא עוד סיבה, אחת מני רבות, לנפילות שהן גורם שכיח לטראומה בקשישים.

פרט למערכת הראייה והשמיעה, גם התפקוד של יתר איברי הקלט החושי הולך ונפגע: חושי הטעם והריח הולכים ומתנוונים ואיתם גובר הסיכון שהקשיש לא יאתר דליפת גז וריח שריפה או לא יזהה טעם של חומרים מסוכנים.

הפגיעה רבת־הפנים במערכת העצבים המרכזית ובקלט החושי היא אחת הסיבות לכך שעילפון (סינקופה) נפוץ בקרב קשישים, לצד מחלות המופיעות בשכיחות גבוהה בגיל מתקדם, דוגמת פרקינסון ואלצהיימר. סיבות נוספות שכיחות לפגיעה בקלט החושי הן הפרעות קצב והפרעות הולכה וכן פגיעה ברפלקס הבארורצפטורים המווסת את לחץ הדם ואחראי על זרימה מספקת בעורקי הקרוטים.

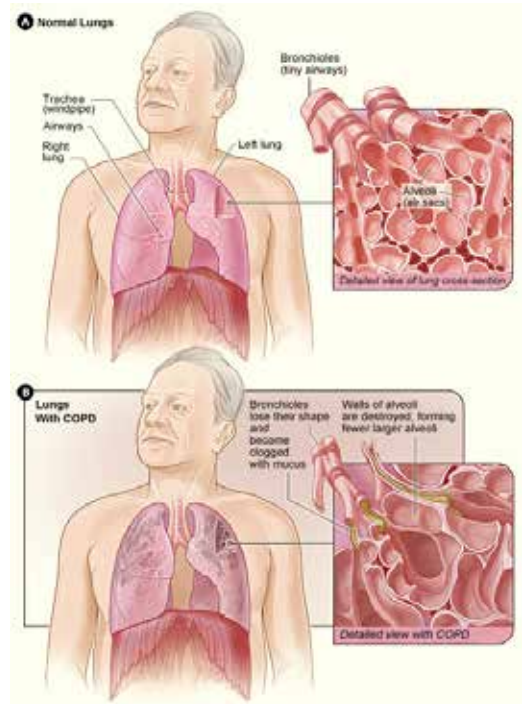
The Internal Ear



איור 18.1 איבר שיווי המשקל באוזן

האוזן הפנימית מורכבת מחלק גרמי ומחלק ממברנוטי שבתוכו זורם הנוזל הלימפתי שנע לפי תנוחת האדם. גם איבר שיווי המשקל מתנוון בקרב קשישים, עובדה היכולה להסביר את שיעור הנפילות הרב בגיל זה.

(מזכה: BruceBlaus, Own work, CC BY 3.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29025011>)



איור 18.2 מצב הריאות ב־COPD

רואים הרס של הנאדיות בעקבות נזק כרוני. הפגיעה בנאדיות גורמת לכליאת אוויר כרונית בבית החזה ובשלב מתקדם מובילה למראה של חזה חביתי (barrel chest).

(ב) מערכת הנשימה

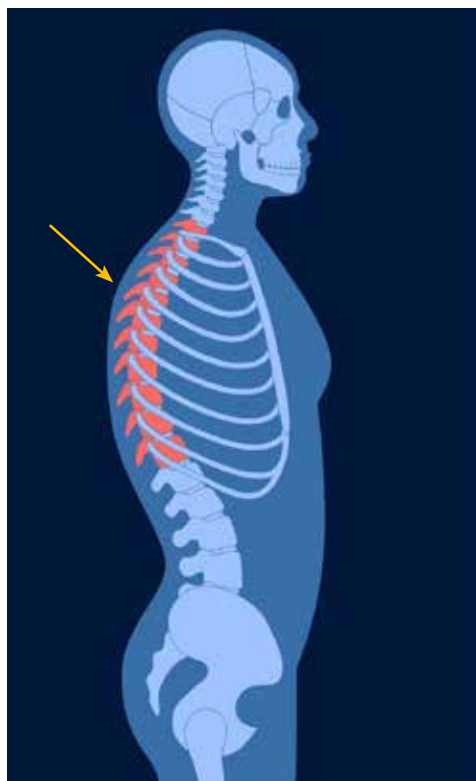
תפקוד מערכת הנשימה נשחק אף הוא בזקנה. במהלך החיים הנאדיות ניזוקות מגורמים שונים וקיבולת הריאות יורדת. יש שינויים ומחלות המשפיעים על מערכת הנשימה. COPD היא מחלה נפוצה באוכלוסייה המבוגרת, כמעט בלעדית בקרב המעשנים (איור 18.2). מחלה נוספת נפוצה היא דום נשימה חסימתי בשינה (obstructive sleep apnea: OSA) שלא רק פוגע בתהליך השינה אלא גם מעלה את לחץ הדם של הריאה, שהוא גורם סיכון לאוטם לב ולשבץ מוחי. יכולה להיווצר מגבלה משנית לקיפוזיס (kyphosis) בעמוד השדרה (תמונה 18.2) שפוגעת ביכולת התרחבות הריאות.

נוסף על כך, תהליך הנשימה יכול להיפגע משנית להסתידות מואצת של הסחוסים הצלעיים והפגיעה המשנית בגמישות הצלעות. הירידה התפקודית של מערכת השרירים כוללת גם את השרירים הבין-צלעיים. בשל כך הנשימה תלויה יותר בתפקוד הסרעפת (כמו בתינוקות), לחץ מכיוון הבטן (בין היתר בגלל אכילה מרובה או שינה פרקדן) יכול לגרום לקשיי נשימה. כל התהליכים והמחלות לעיל מקטינים את נפח הנשימה בכל שלביה, כולל את הנפח המתחלף. כדי לפצות על הירידה בנפח הנשימה גוף הקשיש מגביר את קצב הנשימה. הגוף מסתגל לירידה תפקודית זו כפי שהוא מסתגל לשינויים תפקודיים רבים. הבעיה העיקרית היא שיש רזרבות נמוכות בעת עקה (סטres). כך שאף אם הקשיש מסתדר במצב תפקודי סטטי בסיסי, הידרדרות קלה במצב הנשימה עלולה להיות קריטית עבורו.

פרט לירידה המתוארת בנפח המתחלף, גם מעבר החמצן מהריאות לדם יורד. לחץ החמצן הממוצע בדם עורקי (P_{aO_2}) אצל בוגר בן 20 הוא כ־94 מ"מ, אבל בגיל 70 לחץ החמצן הממוצע בדם העורקי יורד לערך של 80 מ"מ.

(ג) לב וכלי דם

טרשת עורקים היא תהליך שמתחולל במשך שנים רבות, ובמהלכו שומנים מצטברים על דופנות כלי הדם העורקיים וגורמים לתהליך דלקתי כרוני (איור 18.3). בקשישים תהליך זה מגיע לשלבים מתקדמים ומגביר את הסיכון למחלת לב כלילית, שבץ מוחי ומחלת כלי דם היקפית.



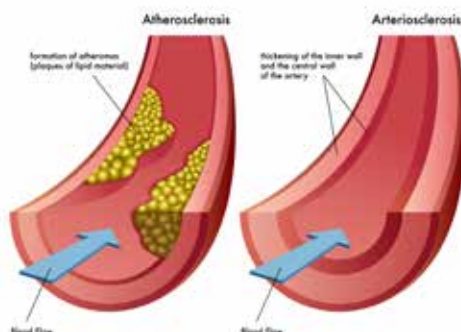
תמונה 18.2 קיפוזיס (Kyphosis) אצל אדם מבוגר
חץ כתום: מצב זה פוגע ביכולת בית החזה להתרחב בעת נשימה ומקשה על תהליך הנשימה.

בעיה נוספת במערכת הלב וכלי הדם היא ירידה בגמישות העורקים עם הגיל ופגיעה בשליטה על לחץ הדם. לחץ הדם עולה, והממצא המאפיין הוא עלייה בלחץ הדם הסיסטולי הגדולה יותר מהעלייה בלחץ הדם הדיאסטולי (טבלה 18.1). חשוב לזכור שאצל קשישים עם יתר לחץ דם, לחץ דם סיסטולי של 120 יכול להיחשב נמוך ולהיות ביטוי להלם.

נוסף על פגיעה בכלי הדם יש ירידה באלסטיות של הלב עצמו וניוון של תאי שריר הלב עם הפחתה בתאי מערכת ההולכה החשמלית. עקב כך קשישים מועדים יותר להפרעות קצב. לשם המחשה, הסיכוי שיופיע פרפור עליות (פרוזדורים) במהלך חייו של אדם בן 40 הוא 25%. אחת הסיבות להפרעות קצב בגיל מבוגר היא תרופתית - שימוש בחוסמי בטא וחוסמי תעלות סידן עלול להגביר את הופעת הפרעות הקצב.

בהתייחס לקצב הלב - חשוב לזכור שטכיקרדיה כסמן ראשוני להלם לא תמיד תופיע בזקנים. ראשית, קצב הלב המרבי מושפע בראש ובראשונה מהגיל, וצפוי להיות נמוך בקרב הקשישים. פרט לכך, תרופות המאיטות את קצב הלב (בייחוד חוסמי בטא) ימנעו את מנגנון הפיצוי המוכר.

המנגנונים שתוארו מובילים בסופו של דבר לשיעורים גבוהים של אי-ספיקת לב. לפי הסטטיסטיקה העדכנית יש אי-ספיקת לב בקרב 6%-10% מהמטופלים בני 65 ומעלה.



איור 18.3 טרשת עורקים

איור המדמה תהליך טרשתי. רואים הצטברות של שומן בדופנות כלי הדם הגורמת גם להיצרות חלל כלי הדם וגם לפגיעה בגמישותו.

טבלה 18.1 ערכי לחץ דם על פי קבוצות גיל ובהשוואה בין נשים לגברים: הערכים עולים ככל שעולים בקבוצת הגיל

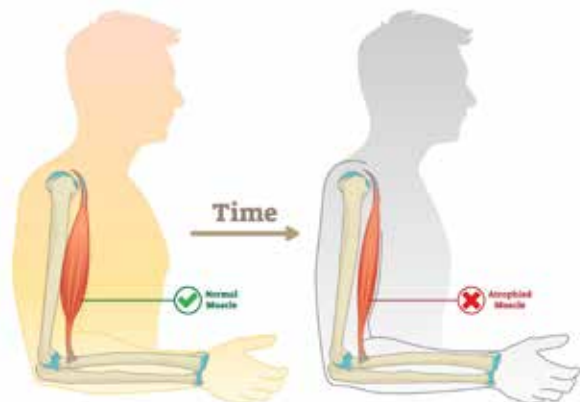
קבוצת גיל	גברים	נשים
40-45	125/83 מ"מ"כ	124/83 מ"מ"כ
46-50	127/84 מ"מ"כ	126/84 מ"מ"כ
51-55	128/85 מ"מ"כ	129/85 מ"מ"כ
56-60	131/87 מ"מ"כ	130/86 מ"מ"כ
>60	135/88 מ"מ"כ	134/87 מ"מ"כ

(ד) המערכת המוסקולוסקלטלית

מערכת השלד והשריר מושפעת מאוד מתהליך הזקנה. בסביבות גיל 30 מסת השרירים והעצמות מפסיקה לגדול, וכמה שנים לאחר מכן חלה נסיגה הן במסת השריר והן במסת העצם, בתלות בחוסר הפעילות ובגנטיקה. עצמות הקשישים הולכות ומאבדות מצפיפותן בשל אובדן מינרלים, ולכן הן פריכות יותר ונוטות להישבר גם בטרומה עם קינמטיקה קלה; יש שלושה שברים אופייניים: שבר בצוואר הירך, שבר בחוליות עמוד שדרה ושבר בשורש כף היד; הנפוץ יותר הוא שבר בצוואר הירך.

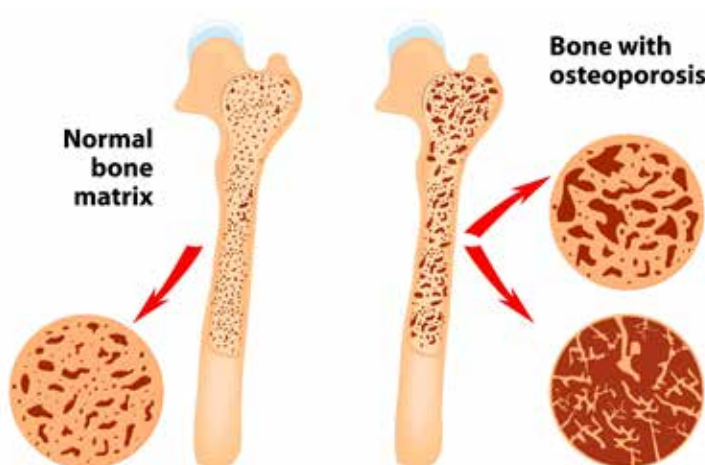
קריסת חוליות עמוד השדרה בשל אובדן המינרלים הגרמיים מובילה לקיפוזיס (kyphosis) ניכר והיא האחראית לירידה בגובה הקשיש. קיפוזיס משפיע גם על הופעת מחלת נשימה מגבלתית (restrictive). נוסף על כך, שיעור לא מבוטל מהקשישים (10% מהגברים ו-18% מהנשים עד גיל 60) מפתחים דלקת מפרקים ניוונית (osteoarthritis) הגורמת להתנפחות המפרקים, לירידה באלסטיות המפרקים, לפגיעה בטווח התנועה שלהם ולשינוי צורתם (איור 18.5). המקום האופייני לפגיעה זו הוא בדרך כלל באצבעות ובמפרקים נושאי משקל.

אשר למסת השריר, הערכות אומדות את אובדן השריר ב־0.5%-1% לשנה מגיל 50, כך שעד גיל 80 יש ניוון של 25%-40% מהמסה המקורית - מצב שנקרא דלדול שרירים (sarcopenia) (איור 18.4). עיקר ההידלדלות נובעת מחוסר שימוש ומאטרופיה משנית. בעת התפרקות סיבי השריר רקמת השריר מוחלפת ברקמת חיבור, ולכן יש ירידה בגמישות השרירים ובחוזקם. הירידה קורית כתלות בפעילות הגופנית, ולכן במקרים של טראומה, ריתוק למיטה או מחלה ממושכת הגורמת לפגיעה בניידות, יוחש תהליך הבלליה של השרירים. במקביל נפגעת גם יכולת השרירים לנצל חמצן. בגיל 90 יש ירידה של כ־50% מהיכולת המקורית. גם פגיעה זו מושפעת ממידת הפעילות. בשל התהליכים המתוארים, גם פעילות פשוטה נעשית מאומצת, ולצד זמן התגובה האיטי, מדובר על צירוף של גורמים חשובים שיכולים להוביל לתאונות, לנפילות ולשיכבה ממושכת במיטה לאחריהן.



איור 18.4 השוואה בין שריר רגיל ובין שריר שעבר אטרופיה

הירידה במסת השריר שיכולה להתרחש מפתולוגיות שונות וקורית גם בתהליך ההזדקנות.



איור 18.5 השוואה בין מבנה עצם תקינה ובין מבנה עצם של אדם עם אוסטאופורוזיס

אפשר לראות כי עצם של אדם עם אוסטיאופורוזיס דלילה יותר, מרווחת ונקבובית יותר, ולכן מועדת לשברים גם בפגיעות קלות.

(ה) מערכות נוספות

ירידה הולכת וגוברת בתפקוד הכליות מובילה לקושי לשמור על מאזן הנוזלים והמלחים בגוף. זו אחת הסיבות שכ-41% מהקשישים נמצאים בהתייבשות יחסית (בעיקר בשל פגיעה במנגנון הצמא). מצד שני, עירוי, בייחוד במטופלים עם אי-ספיקת לב, גורם להעמסת נוזלים העלולה לגרום לבצקת ריאות. פרט למלחים, נפגע גם מאזן הסוכר וגדל הסיכוי להופעת סוכרת סוג 2 (אצל כ-8.3% מהאוכלוסייה) עם התחלואה הנלווית שלה.

איבר נוסף שנפגע הוא הכבד, בין היתר משנית לירידה בזרימת הדם התוך-כבדית. בשל כך תהליך פירוק רעלים ותרופות מואט. לכן לשימוש בתרופות במינונים שגרתיים יכולה להיות השפעה לא צפויה ואף לגרום להרעלה. במקביל יש ירידה בתפקוד מערכת החיסון, ולכן הסכנה של הופעת זיהום הולכת וגדלה, ואכן ספסיס הוא אחד הגורמים למוות בקרב קשישים.

מצבי התחלואה השכיחים

יש קבוצות סיכון לתמותה משנית לטראומה בקשישים והן כוללות: בני 75 ומעלה, אנשים החיים בגפם, מוות של בן או בת זוג בתקופה האחרונה, אשפוז לאחרונה, חוסר ניידות ובעיות נפשיות. חשוב לזכור שמקרי טראומה יכולים להיות תוצאה של פגיעה א-טראומטית מקדימה, למשל תאונת דרכים בגלל התקף אפילפטי של הנהג. בהקשר זה אפשר למנות גם סינקופה עם חבלה משנית והירדמות (במהלך נהיגה, תוך כדי עישון וכו'). אומנם תופעות אלו קיימות בכלל האוכלוסייה, אך הן חשובות ושכיחות יותר בקרב הקשישים בשל מחלות הרקע והשינויים שתוארו.

**הגורם הראשון במעלה למוות ולנכות בקרב קשישים הוא נפילות.
הגורם השני הוא תאונות דרכים.**

קשישים שנוהגים נמצאים בסיכון גבוה יותר להיות מעורבים בתאונה אף אם אינם נוהגים מהר, מפאת התגובות האיטיות למצבי דחק והפעלת שיקול דעת מוטעה או עיכוב בהפעלת שיקול דעת ותגובה מעוכבת באירוע חירום. גם כהולכי רגל הקשישים מועדים יותר להיפגע על ידי רכב עקב ירידה בחדות החושים ותגובתם האיטית. פרט לכך, קשישים חשופים לפגיעות ראש ולכוויות, והם גם מועדים לשוד או להתעללות.

נפילות

נפילות שכיחות יותר בקרב קשישים והן גורם מרכזי בתחלואה ובתמותה. שכיחות הנפילות היא מטופל אחד מכל שלושה מעל גיל 65. אצל בני 72 ומעלה תהיה בממוצע נפילה אחת לשנתיים, ונפילה אחת לשנה אצל בני למעלה מ־80. יש מגוון רחב של סיבות לשכיחות הנפילות. סיבה אפשרית היא נטילת תרופות שגורמות לפגיעה בשיווי המשקל. סיבות נוספות הן: ירידה בחוזק שרירי האגן והגפיים התחתונות, פגיעה בגמישות המפרקים, בעיות בתבנית ההליכה, ראייה לקויה או תפקודים קוגניטיביים ירודים.

העצמות הפגיעות ביותר בעקבות נפילות הן עצמות האגן והירך (תמונות 18.3, 18.4). לשברים אלו משמעות תפקודית רבה, היות שפעמים רבות מדובר על נקודת הידרדרות של המטופל שממנה הוא הולך ודועך. פעמים רבות קשיש שנפל לא יתאושש מפגיעתו, יהיה מרותק למיטה ויהפוך לסיעודי. אף אותם שהחלימו מפגיעתם לא תמיד הולכים כתמול שלשום וזקוקים להסתייעות תדירה הן במכשירי עזר והן במטפלים. קשישים אלו נוטים לחשוש מנפילה חוזרת ומגבילים את ניידותם, דבר שעלול לגרום לדיכאון.



תמונה 18.4 שבר בראש עצם הירך (Femur)

השבר הנפוץ במפרק הירך יכול לגרום לפגיעה גדולה ביכולת הניידות והעצמאות של הנפגע.



תמונה 18.3 שבר באגן

שבר זה נפוץ מאוד בקרב קשישים. חץ אדום: השבר באזור השכיח.

אנמנזה

אשר לאנמנזה, יש אתגר לא מבוטל בייחוד בקשישים עם דמנציה. אף אם הקשיש מתקשר ומודע למצבו הרפואי הוא עלול לשכוח פרטים, להתבלבל או למסור מידע לא רלוונטי שיגרום לטעות באנמנזה. כמקובל, אם מתאפשר, איסוף המידע יהיה בעדיפות ראשונה מהקשיש עצמו. מקורות מידע חלופיים יכולים להיות בני משפחה, מטפל, שכנים, חברים ובדגש מיוחד מסמכים רפואיים שיכולים לעיתים להיות מקור המידע האמין היחיד. מסמכים אלו יכולים להכיל מידע על מחלות רקע, תרופות בשימוש קבוע והסיבות לשימוש בהן, טיפולים רפואיים משמעותיים, אשפוזים לאחרונה, ניתוחי עבר, הנחיות רפואיות, תפקוד בסיס, מצב קוגניטיבי, פרטים על הרופא המטפל ורגישויות.

מידע חשוב נוסף אפשר להשיג מסביבת הקשיש וממראהו הכללי. אפשר ללמוד רבות ממראה המטופל: בודקים סימני מצוקה, היגיינה אישית, סימני הזנחה, קכקסיה (cachexia) - סינדרום מטבולי הבא לידי ביטוי ברזון, סימני התעללות או עדות לניתוחי עבר; אפשר ללמוד מסביבת המגורים שלו: בודקים אם הקשיש מתגורר בגפו, אם יש מטפל זר, אם יש משפחה מלווה, מה מידת הטיפול והניקיון של הדירה; אפשר ללמוד מעוד פרטים משלימים כגון: בבקווי תרופות ריקים בפח, מחולל חמצן, הליכון, כיסא גלגלים ועוד.

קושי בתשאול קיים גם אצל ילדים, אצל אנשים הנתונים להשפעת אלכוהול או סמים או מחוסרי הכרה; אך עיקר הקושי בקרב קשישים נעוץ בעובדה שעם הגיל יש עלייה בשכיחות מחלות הרקע ובשימוש קבוע בתרופות שיש להן השפעה מערכתית לצד צמצום הרזרבה הפיזיולוגית של הקשיש, ולפיכך האפשרות לטעויות בתשאול היא גבוהה.

הטיפול בקשיש

השלב הראשון בטיפול בקשיש, כמו בכל סכמת טיפול, הוא דאגה לבטיחות של המטפל והמטופל. בנוגע לבטיחות המטופל, יש לזכור שהקשיש מסוגל להגן על עצמו פחות ממטופל אחר בייחוד אם הוא סובל מנכות או ממחלות המגבילות את הניידות שלו ואת התקשורת עם הסביבה.

אם המטופל בהכרה מלאה וצלול אפשר להמשיך בטיפול לפי הסכמה ABCDE. אם מזהים בלבול, מבררים אם הבלבול קדם לטראומה, או אם הטראומה התרחשה ראשונה ובעקבותיה הופיעו בלבול וקהות חושים. כדי לקבל תמונה ברורה אפשר להסתייע במידע מהסביבה - כך אפשר להעריך את מצב הבסיס של המטופל (המצב התפקודי הבסיסי, ה־baseline), ואותו משווים למצב הנוכחי וכך אפשר להסיק מסקנות. המשך הטיפול, לפי הסכמה המקובלת, הוא סבב ראשוני הכולל ABCDE וסבב שניוני.

(A) נתיב אוויר (Airway and C-Spine Protection)

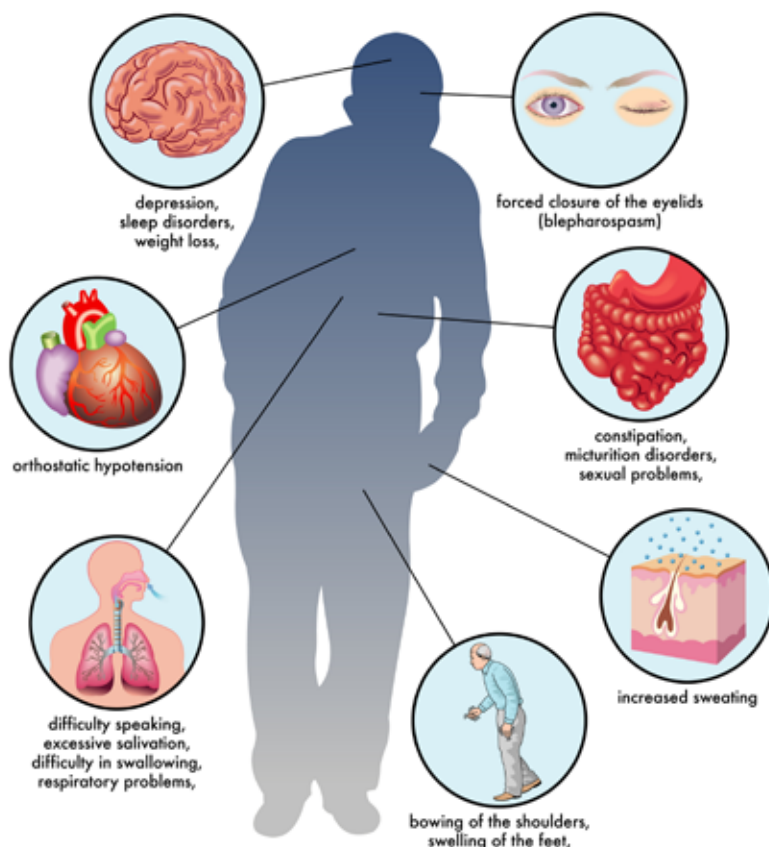
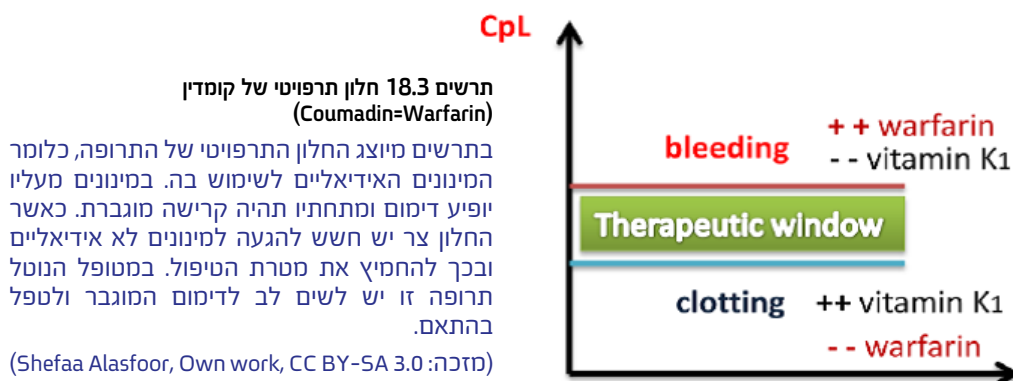
בודקים נתיב אוויר ומוודאים שהוא פתוח ומאובטח. אצל מרבית המטופלים הגורם העיקרי לחסימת נתיב האוויר הוא צניחת בסיס לשון. אצל הקשיש מצטרף מרכיב נוסף לחסימת נתיב האוויר והוא נפילת החך העליון לאחר איבוד טונוס מוחלט של דרכי האוויר. טרם פתיחת נתיב האוויר פותחים את הפה ומסלקים הפרשות.

אם יש שיניים תותבות - הגישה הטיפולית תלויה נסיבות: מצד אחד השיניים התותבות הן גוף זר ומגבילות את הגישה לחלל הפה ועלולות אף להישאף אל דרכי האוויר, אך מצד שני הן מייצבות את הלסת ומאפשרות הידוק מסכת הנשמה כראוי. השאיפה היא להשאיר את השיניים התותבות כל עוד אפשר. אך אם הן מפריעות, בעיקר בשל ביצוע פרוצדורות כדוגמת אינטובציה, מוציאים אותן.

(B) נשימה (Breathing and Ventilation)

תיתכן ירידה תפקודית הדרגתית בנשימה, לכן הרזרבה הנשימתית נמוכה. במקביל, עצמות בית החזה פריכות, ולכן יש סיכוי מוגבר לשברים בצלעות עם פגיעה משנית ברקמת הריאה. בשל כך בטרומה התפקוד הנשימתי הנמוך עשוי להתלוות לפגיעות חמורות הכוללות חזה אוויר בלחץ, חזה אוויר פתוח, חזה דם מסיבי, חזה מרפרף, טמפונדה לבבית או חבורה לבבית. המשמעות של איחור באיתור של אחת מפגיעות אלו היא ראשונה במעלה. יש לזכור שעלולה להופיע החמרה נשימתית, עד כדי אי־ספיקה ולעיתים אף מוות תוך דקות. אין לחשוש ממתן חמצן גם בחולי COPD. מתברר שהסכנה בקרב מטופלים אלו מהעשרה בחמצן היא פחותה יותר מכפי שחשבו בעבר. הגישה המומלצת היא מתן חמצן במקביל לניטור צמוד ואינטובציה (צְנָרָה) במידת הצורך.

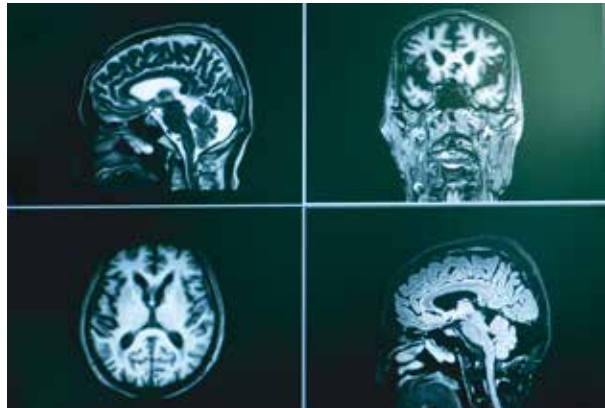
קשישים הנוטלים תרופות ממשפחות אלו, בייחוד קומדין בשל היותה בעלת טווח טיפולי צר (תרשים 18.3), יכולים להתייצג בדימומים מוגברים אף בטראומה עם קינמטיקה קלה. במידת האפשר ובמגבלות זמן הפינוי, מומלץ לברר אילו תרופות הקשיש נוטל ולמסור דיווח לבית החולים כדי למקד את תשומת ליבם ולהחיש את המענה הרפואי שהוא יקבל עם הגעתו.



איור 18.6 השפעת מחלת פרקינסון על המערכות בגוף

(D) מצב הכרה והערכה נוירולוגית (Disability and Neurologic Assessment)

ההערכה הנוירולוגית של הקשיש יכולה להיות אתגר עקב התנוונות מערכת העצבים עם הגיל וייתכנות של שיתוף פעולה מוגבל. לא אחת, כחלק מתפקוד הבסיס, יהיו קהות חושים, תגובות איטיות, השפעת תרופות ניכרת לצד פגיעה ממחלות רקע רלוונטיות, דוגמת שבץ, אלצהיימר ופרקינסון (איור 18.6, תמונה 18.5). בשל כך חשוב לברר את המצב התפקודי הבסיסי של המטופל ואותו להשוות למצב בזמן אמת. בשל השכיחות הגבוהה יחסית יש לחשווד בסינקופה כגורם הטראומה; המשמעות הפרקטית היא שאזי יש צורך לברר את סיבה הסינקופה.



תמונה 18.5 אלצהיימר

בתמונה רואים השוואה בין MRI של אדם עם אלצהיימר (A) ובין MRI של אדם בריא באותה קבוצת גיל (B). ההופעה של צבע שחור רב יותר מצביעה על כך שיש אטרופיה (הידלדלות) מסוימת של רקמת המוח. אפשר לראות במבט על כי המוח של האדם עם אלצהיימר בעל נפח קטן יותר.

(E) חשיפה (Exposure and Environmental Control)

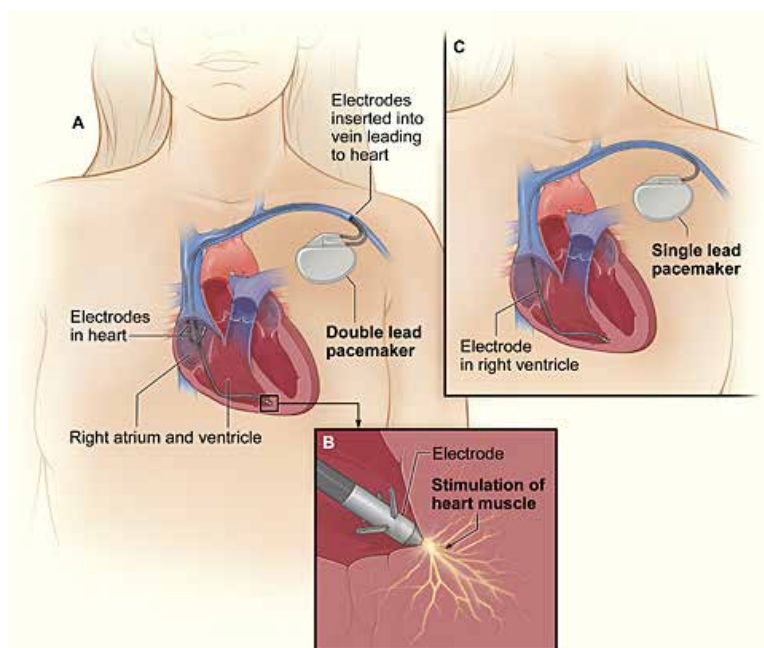
במרכיב זה של סכמת הטיפול חשוב לזכור שטמפרטורת הגוף הבסיסית אצל קשישים נמוכה מטמפרטורת הגוף הרגילה. כמו כן, בדרך כלל לקשישים יש פחות שומן לבידוד הגוף מהסביבה החיצונית ומסת שריר פחותה ליצירת חום. מרכיבים אלו גורמים לכך שאוכלוסיית הגיל השלישי נמצאת בסיכון לפתח היפותרמיה. בשל כך יש לשים דגש מיוחד על שמירת חום גופם באמצעות שמיות, חימום ואם יש צורך בהחזר נוזלים (מחוממים). בכל טראומה, במסגרת ההכנות לפינוי, יש להקפיד על קיבוע מלא ללוח גב. יש להיזהר בעת הקיבוע, שכן רקמת השריר המבודדת קטנה יותר והמערכת הגרמית מדולדלת אף היא (אוסטאופורוזיס). יש דיווחים על הופעת פצעי לחץ בעת קיבוע ממושך ללוח גב.

עם סיום הסבב הראשוני והטיפול בפגיעות מסכנות החיים, ממשיכים כרגיל בסבב השניוני. סבב זה אינו שונה מהפעילות המקובלת הכוללת גם בדיקה, תשאול וניטור, אך יש לתת את הדעת לדגשים שהוזכרו בנוגע לטיפול בקשישים. בעת הבדיקה ולקיות האנמנזה יש להתייחס אל הקשיש המטופל בכבוד. חשוב ליצור קשר עין איתו ולדבר אליו בגובה העיניים - בלי התנשאות, כשווה אל שווה. על המטפל לגלות אִמפתיה כלפי הקשיש ולא לזלזל באינטליגנציה שלו בגלל קשיי תקשורת. יש להביא בחשבון שיתכן שלקשיש קושי לדבר או שאינו יכול לדבר כלל, אך אין פירוש הדבר שאינו מבין. אין להתייחס אל הקשיש כאל ילד, אלא פונים אליו בשם המשפחה ("אדון נחמני") או כפי שהקשיש הציג את עצמו ולא בכינויים או תארים מקטינים אחרים (דוגמת "סבא" או "דוד"). יתרה מזאת, גם כאשר אפשר לתשאל אחרים בנוכחים בסביבה, כגון מטפל או בן משפחה, אין לעשות זאת כתחליף לתקשורת ישירה עם הקשיש. על השאלות להיות ענייניות, ויש להפנות אל הקשיש שאלות פתוחות ככל האפשר ("איך אתה מרגיש?" ולא שאלות סגורות ("כואב לך?") כדי שלא יענו לשאלות אלו תשובות של 'כן' ו'לא'.

בשל התפתחות איטית של הסימנים והופעה קלה של כמה מהם, קשה להעריך את המצב במלואו, ולכן יש לנטר את מצב הנפגע כל הזמן. בשל קושי זה, חשוב מאוד להתמקד במכאניזם הפגיעה ובהיסטוריה של המטופל.

מתבוננים במטופל ובודקים בצורה מקיפה את מראהו, צבע עורו וסימני מצוקה אחרים (עם דגש על תבנית הנשימה). כדי להעריך מצב התייבשות אפשר לבדוק את רטיבות הלשון והעפעפיים, לבדוק מילוי קפילרי ולאמוד את גמישות העור (turgor). בעת בדיקה נירולוגית חשוב לבדוק את יכולת ההליכה (במידת האפשר), כמו כן חשוב ללחוץ ידיים עם המטופל כדי להשוות סימטריות של העוצמה ולאמוד כוח גס. אצל כל מטופל יש לשים לב להתנהגות, ליכולת הדיבור ולשטף הדיבור, לתנועות לא רצוניות ולשיווי המשקל וכן להיות ערים לסימני התעללות.

בבדיקה מחפשים עדויות למידע רפואי שלא התקבל בתשואול, כולל אוושות קרטידיות, קוצב מושתל (איור 18.7), סימני צלקת מניתוחים וציד נלווה כולל אמצעי הזנה, כגון זונדה או PEG (תמונה 18.6) וקטטר. בשלב זה, אם הדבר לא נעשה עדיין, יש לתת העשרה בחמצן. להעשרה בחמצן לקשישים חשיבות יתרה בשל ירידה בלחץ החמצן וכן עקב שכיחות מחלות ריאה, לב וכלי דם שיש לנטר (COPD אינו סיבה להימנע ממחצן). בעת מתן תרופות יש לזכור שמטבוליזם התרופות, כלומר קצב הספיגה וההפרשה של התרופות, משתנה והשפעתן עלולה להיות חזקה מהצפוי, וכמו כן משך השפעתן יכול להתארך. יש לשים לב במיוחד לתרופות אנטיכולינרגיות (anticholinergic) ואם אפשר מוטב לצמצם את השימוש בהן.

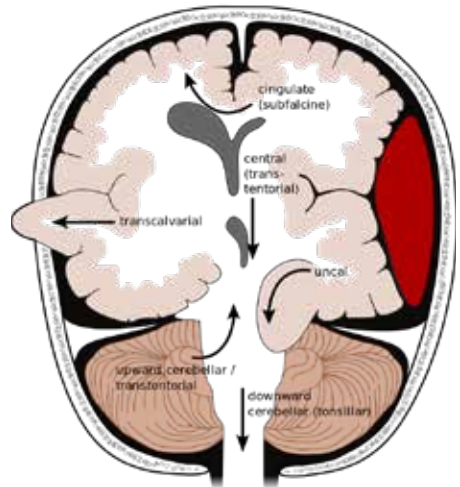


איור 18.7 קוצב לב

קוצב הלב מושתל לחולים שיש חשש להפסקה בפעימות הלב שלהם. קוצב הלב מותקן על השטח החיצוני של בית החזה ומחובר באמצעות אלקטרודות אל הלב. אפשר יהיה לראותו כבליטה בבית החזה כפי שרואים בתמונה.



תמונה 18.6 PEG: שיטת הזנה דרך העור



איור 18.8 סוגי הרניאציות (Herniation)

מימין (באדום): אפשר לראות דימום אפידורלי שמעלה את הלחץ התוך-גולגולתי ודוחק את רקמת המוח עד ליצירת הרניאציה. אפשר לראות שיש סוגים שונים של הרניאציות מוחיות. אלו הלוחצות על גזע המוח הן המסוכנות ביותר משום שהן עלולות לפגוע במרכזי הנשימה והדופק.

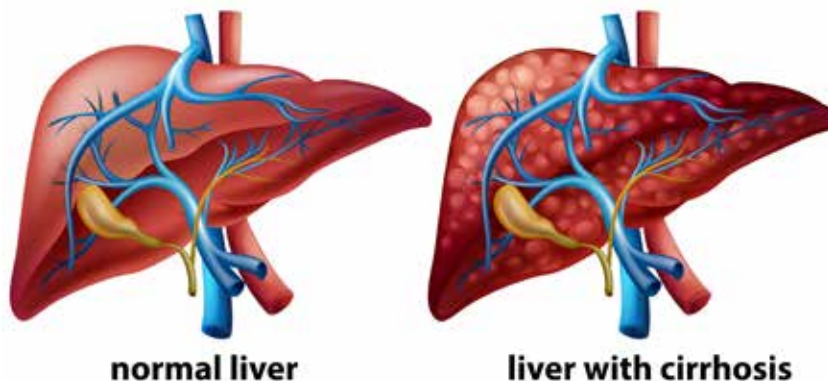
Brain_herniation_types.svg: User: Delldotderivative (מזכה)
work: RupertMillard (talk), Brain_herniation_types.svg, CC
(BY-SA 3.0)



תמונה 18.7 דימום סאבדורלי

חץ שחור: דימום ורידי משום שבחלל זה יש מבנים ורידיים גדולים (סינוסים). דופן הוורידים נחלש עם הגיל, ולכן כל מכה קטנה בראש יכולה לגרום לקרע בכלי ולדימום אל החלל הסאבדורלי. דימום מסיבי עלול לגרום להרניאציה (herniation) כפי שאפשר לראות באיור 18.8.

(מזכה: James Heilman, MD, Own work, CC BY-SA 3.0)



איור 18.9 צירוזיס (שחמת הכבד, Cirrhosis)

השוואה בין כבד של אדם בריא ובין כבד של אדם עם מחלקה כרונית הסובל מצירוזיס. אפשר לראות כי רקמת הכבד נעשית מגורגרת ואף גודל הכבד מתכווץ. הדבר יתבטא בירידה בתפקודי כבד.

פציעות טראומה שכיחות בקרב קשישים

חבלות ראש

אצל קשישים בדרך כלל רואים שבמקרי טראומה רבים יש גם חבלת ראש. עם הגיל רקמת המוח קטנה ועקב כך גדל המרווח בינה ובין קופסת הגולגולת. כלי הדם הוורידיים (perforating veins) נמתחים ברווח שנוצר ונעשים פגיעים יותר, ואף חבלה קטנה עלולה להוביל לדימום. אומנם מדובר על דימום ורידי עם זרימה קטנה, אך בשל החלל הפתוח שאליו מתנקז הדם ובגלל היעדר לחץ של הרקמה ההיקפית, אפשר לעיתים לראות הצטברות רבה של דם. נוסף על כך ייתכן שבגלל הגיל והשפעת תרופות תהיה פגיעה במנגנון הקרישה והטסיות, והדימום בסופו של דבר יכול להוביל לדחיקה של רקמת המוח וללחץ מקומי עד כדי הרניאציה (herniation) של המוח עם סכנת חיים. אך בדרך כלל זהו תהליך איטי ללא ביטוי סימפטומטי עד להופעת נזק רקמתי למוח (איור 18.8). לכן עדות לדמם מוחי ישן בהדמיות CT היא ממצא שכיח. בגלל שינויים רקמתיים אלו, דימום סובדורלי (וריד) (תמונה 18.7) בקרב קשישים הוא שכיח יותר מדימום אפידורלי (עורקי) המופיע בדרך כלל אצל ילדים. אומנם פגיעה מוחית בגלל דמם מוחי בטראומה פחות שכיחה אצל קשישים לעומת צעירים, אבל בקרב קשישים הנזק יכול להיות בלתי הפיך, ולכן התמותה גדלה.

טראומה לחזה

התמותה מפגיעת חזה והסכנה להופעת דלקת ריאות בעקבותיה גדולות אצל הקשישים בהשוואה לצעירים: כל צלע שנשברת מגדילה את סיכויי התמותה ב-19% והסיכוי לדלקת ריאות גדל ב-27%. בשל הסיכונים הרבים של פציעות החזה יש לשמור על רמת חשד גבוהה להופעת פגיעות טראומה אצל מבוגרים אף בהיעדר ביטוי קליני. בקרב קשישים יש נטייה לפגיעות חמורות ובייחוד לשברים בטראומה קלה. לכן יש להקפיד על קיבוע נכון של האגן, בהקשר הקליני המתאים, כבר בשלב מוקדם כדי למנוע נכות עתידית. כפי שהוזכר, הפרעה בתפקוד הכבד עולה עם העלייה בגיל המטופל. במקרים של אתיליזם (שתיית אלכוהול מרובה) אצל מטופל הצורך באלכוהול בקביעות או מטופל עם הפטיטיס כרוני, הפגיעה בכבד חמורה אף יותר (איור 18.9). אצל מטופל עם שחמת הכבד (צירוזיס) שאלה נוספת טראומה שמתבטאת בפגיעה קשה, מצבו הרפואי יכול להיות חמור בשל הפגיעה הנלווית למנגנון הקרישה.

כוויות

מקרי כוויות אף הם קשים יותר בקרב קשישים ויש עלייה בתמותה מכוויות בשל כמה סיבות. ראשית, היות שבדרך כלל כמות השומן בגוף פחותה אצל קשישים יש פחות הגנה והדבר עלול לגרום לנזק נרחב לרקמות עמוקות. פרט לכך, הירידה בתפקוד מערכת החיסון גורמת לעלייה בסיכון להופעת זיהומים בגלל הפגיעה במנגנון ההגנה של העור. בעיה נוספת קיימת במאזן הנוזלים. דרך הרקמה הפגועה וסביבה אובדים נוזלים בכמויות משמעותיות. לא תמיד אפשר להחזיר נוזלים בעירוי תוך־ירידי - במקרה של אי־ספיקת לב ובשל החשש לבצקת ריאות. כמו כן, ברקמת העור המזדקנת יש פחות בלוטות זיעה וחלב ורקמת היפודרמיס והדבר יכול לגרום לפגיעה בווטוסות חום הגוף ולהגברת הסיכון להיפותרמיה. גם ההחלמה מכוויות קשה יותר בקרב קשישים. כל נפגע כוויה זקוק לחלבון בכמויות מוגברות כדי להתמודד עם שיקום הרקמות. רמת החלבון והאלבומין בגוף הקשיש היא פעמים רבות נמוכה, לעיתים נוספת אליה תת־זונה ואף הן מקשות על ההחלמה.

בכל מקרה של כוויות יש לתת דגש לסימנים המחשידים להזנחה ולהתעללות פיזית או מינית.

פינוי

כמו במקרי טראומה אחרים, חשוב ביותר להקפיד על פינוי מהיר למתקן רפואי מתאים. גם בהיבט זה, הקשיש הוא שמקבל את ההחלטה לגבי כל הצעדים הטיפוליים שבידינו להציע. אם הוא צלול, זכותו של הקשיש לסרב לטיפול או לפינוי, ולמשפחה אין מעמד חוקי בהקשר זה, אלא אם כן יש אפוטרופוס שמונה על ידי בית המשפט או אם הקשיש דמנטי או שאינו מתקשר. לכן, כמו בכל טיפול רפואי, יש להסביר למטופל עצמו, לוודא שהוא מבין ולקבל את הסכמתו מדעת. וחשוב להיזהר שלא להיגרר למלא את בקשות בני המשפחה או המטפלים של הקשיש אם הן לא עולות בקנה אחד עם בקשת המטופל.

להזכירכם - החובש אינו עושה הבחנות כאלה. אדם מוגדר דמנטי על ידי הרופא המטפל, נירולוג או בית משפט.

נכים

בטיפול בנכים יש להביא בחשבון מגבלות פיזיות, שימוש במכשירי עזר כגון כיסאות גלגלים, מכשירי הנשמה ואחרים שיש להביא אותם בחשבון בטיפול ובפינוי. על המטפלים להיות ערים לדקויות ולצרכים המיוחדים כדי לתת את הטיפול ההולם ולהימנע מדעות קדומות. יש להדגיש שאין מדובר כאן בטיפול בנכות עצמה אלא בטיפול חירום בלבד.

עקרונות טיפולי החירום וטיפול השגרה זהים בין מטופלים עם נכות ובין מטופלים ללא נכות.

מן המטפל נדרשת מודעות להתאמות הנדרשות למטופל הנכה.